

Número EU CT	2024-515561-34-00
Número NCT	NCT06571149
Título del estudio	Seguridad y eficacia de la trombólisis intravenosa en pacientes con ictus isquémico e ingestión reciente de anticoagulantes orales directos: DO-IT - The DOAC Intravenous Thrombolysis trial (Ensayo de trombólisis intravenosa con DOAC)
Patrocinador	Insel Gruppe AG Hospital Universitario de Berna, Inselspital Freiburgstrasse, 3010 Berna, PD Dr. med. Thomas Meinel, Departamento de Neurología

Sinopsis del protocolo

Justificación

El uso de anticoagulantes orales directos (DOACs) se ha impuesto como el tratamiento de prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular (FA) no valvular. Además, no dejan de aparecer nuevas indicaciones para los DOAC, como el tratamiento de enfermedades vasculares (trombosis venosa, embolia pulmonar, cardiopatía coronaria estable y arteriopatía periférica). Se calcula que, desde la transición de los antagonistas de la vitamina K (AVK) a los DOAC, uno de cada cinco o seis pacientes con ictus susceptibles de recibir trombólisis intravenosa (TIV) tiene prescrito un DOAC. Se prevé que en las próximas décadas se duplique la prevalencia de la FA y, por tanto, la población en tratamiento prolongado con DOAC.

Las directrices recomiendan excluir a los pacientes con ingestión reciente de DOAC (<48 horas antes) de recibir TVI en caso de que sufran un ictus isquémico. Esta recomendación se basa en la presunción de un mayor riesgo de hemorragia intracraneal sintomática (HICs) en pacientes que toman DOACs, pero los datos hasta la fecha no han apoyado esta preocupación. En modelos experimentales de ictus isquémico, el pretratamiento con DOAC no aumentó el riesgo de hemorragia tras un TIV, a diferencia del pretratamiento con AVK. Estos resultados concuerdan con la totalidad de las observaciones clínicas realizadas hasta la fecha, que indican tasas similares o inferiores de IHQs y tasas similares de resultados funcionales excelentes tras un TIV en pacientes tratados con DOACs en comparación con pacientes no anticoagulados. Sin embargo, no podemos excluir el sesgo de selección y la confusión por indicación como explicaciones de estos resultados observacionales en pacientes con ictus isquémico agudo (AIS) que toman DOAC y necesitamos datos aleatorizados definitivos para guiar la práctica clínica a este respecto.

Objetivo

El ensayo DO-IT es una prueba definitiva de la hipótesis de que la estrategia de utilizar un TIV (con Alteplasa o Tenecteplasa) es superior a la atención estándar para lograr un mejor resultado (resultado funcional cuantificado por un cambio en la escala de Rankin modificada, mRS) a los 90 días $\pm$ 2 semanas en pacientes con ictus isquémico agudo (AIS) con ingestión reciente de DOAC que, por lo demás, son elegibles para la TIV de acuerdo con las normas locales de atención.

Criterios de valoración principales del ensayo

El criterio principal de valoración de la eficacia es la escala de Rankin modificada (mRS) a los 90 días $\pm$ 2 semanas del ingreso. Los principales resultados de seguridad son el sICH en las 36 horas siguientes a la aleatorización, cualquier hemorragia intracraneal a las 24 $\pm$ 12 horas, la mortalidad por todas las causas hasta 7 días después del ingreso o hasta el alta, las hemorragias extracraneales graves, el edema orolingual hasta 24 $\pm$ 12 horas después de la aleatorización y la

mortalidad por todas las causas a los 90 días.

Criterios de valoración secundarios

Los criterios de valoración clínicos secundarios son el buen resultado funcional dicotomizado (mRS, 0-2 o vuelta al valor basal a los 90 días $\pm$ 2 semanas), el cambio en la gravedad del ictus (escala de ictus de los Institutos Nacionales de Salud y volumen de ictus isquémico) entre el valor basal y las 24 $\pm$ 12 horas, la calidad de vida relacionada con la salud (EuroQol 5D-3L) en a los 90 días $\pm$ 2 semanas, el índice de Barthel ampliado a los 90 días $\pm$ 2 semanas y el destino al alta (domicilio, alta temprana con apoyo, centro de rehabilitación, cuidados a largo plazo, fallecimiento).

Diseño del ensayo

Estudio multicéntrico (N= ~100) prospectivo, aleatorizado (1:1), abierto y ciego. Los sujetos participan durante 90 días $\pm$ 2 semanas.

Población del ensayo

Se incluirá a los pacientes con los siguientes criterios: pacientes con SIA que reúnan los requisitos para recibir trombólisis intravenosa según el tratamiento estándar y un déficit incapacitante según el criterio del médico tratante, pacientes con ingestión de DOAC en las 48 horas anteriores a la inscripción o pacientes con una prescripción en curso de DOAC pero de los que se desconoce el momento exacto de la última ingesta. Además, los pacientes o bien pueden ser aleatorizados en un plazo de 4 horas y 15 minutos y tratados en un plazo de 4 horas y 30 minutos a partir de la última hora de pozo conocida o bien la RM muestra un patrón de "DWI-FLAIR-mismatch" indicativo de una lesión isquémica aguda $\leq$ 4,5 horas y el tratamiento puede iniciarse en un plazo de 4,5 horas a partir del reconocimiento de los síntomas (por ejemplo, al despertarse).

Se excluirá a los pacientes con los siguientes criterios: pacientes de edad < 18 años, contraindicaciones para la TIV según el estándar actual de atención de los médicos tratantes con la excepción de la ingesta reciente de DOAC como se especifica más arriba, intención de reversión mediante agentes de reversión específicos o inespecíficos, embarazo o mujeres en período de lactancia. pacientes con trombectomía mecánica prevista tendrán un límite del 20% de la población del ensayo. Si se alcanza este número, se aplicará el siguiente criterio de exclusión adicional: Tratamiento previsto o planificado con estrategias de reperfusión endovascular

Intervenciones

La intervención experimental consiste en la administración intravenosa de Alteplasa o Tenecteplasa y el mejor tratamiento médico (TMO) según las directrices aplicables. Alteplasa/Tenecteplasa se administra según el tratamiento estándar. La dosis estándar de Alteplasa o Tenecteplasa intravenosa se administrará según las directrices locales. Las dosis de tenecteplasa superiores a 0,25 mg/kg de peso corporal están expresamente prohibidas, ya que las directrices no lo recomiendan debido a las complicaciones hemorrágicas asociadas. Los pacientes asignados aleatoriamente al grupo de control recibirán únicamente TMO según las directrices vigentes.

Consideraciones éticas relativas al ensayo clínico, incluido el beneficio esperado para el sujeto individual o el grupo de pacientes representados por los sujetos del ensayo, así como la naturaleza y el alcance de la carga y los riesgos.

La población diana está formada por pacientes gravemente enfermos con SIA. El SIA suele ir acompañado de una disminución del nivel de conciencia, de la percepción o de déficits neurológicos. Esto implica que los pacientes afectados son vulnerables. No existe un grupo sustituto para la cohorte del ensayo, por lo que se investiga esta población vulnerable de pacientes.

La administración intravenosa de Alteplasa/Tenecteplasa en pacientes con SIA tras la ingesta de DOAC podría ser beneficiosa. Dado que se sabe que la TIV reduce la discapacidad en pacientes con SIA sin ingesta reciente de DOAC, se espera un beneficio similar en términos de reducción de la dependencia funcional en pacientes con ingesta reciente de DOAC si el tratamiento es seguro. En cuanto a los riesgos, la TIV puede provocar hemorragias, siendo la hemorragia intracraneal sintomática el principal problema. Sin embargo, varios estudios de cohortes observacionales retrospectivos recientes, incluidos

metaanálisis, no encontraron pruebas de un aumento significativo de las complicaciones hemorrágicas. Pruebas indirectas de ensayos clínicos aleatorizados y datos de animales apoyan la suposición de que la lisis es segura a pesar del uso reciente de DOAC. Los pacientes del grupo de control tienen un mayor riesgo de oclusión persistente de los vasos, lo que puede agravar su discapacidad. Por otro lado, podrían tener un menor riesgo de complicaciones hemorrágicas.

Todas las visitas clínicas y tratamientos (a excepción de la administración de TIV, que no es estándar en todos los centros participantes) son estándar de atención según las directrices internacionales actuales. Dependiendo del estándar de atención institucional de los centros, una carga adicional para el paciente podría ser la visita clínica a los 90 días $\pm$ 2 semanas después del tratamiento, que también puede sustituirse por una entrevista telefónica.